

Эзофагеальное стентирование при раке пищевода

Жураев Ш.Ш., Байтилеуов Т.А., Шайхиев Е.У., Садыков Н.К., Шокебаев А.А.

Национальный научный центр хирургии им. А.Н. Сызганова

Карцинома пищевода является относительно часто встречающимся заболеванием с неблагоприятным прогнозом. В Республике Казахстан проблема заболеваемости раком пищевода является одной из наиболее актуальных. Ежегодно в республике выявляется свыше 1500 новых пациентов с данной патологией, при этом, смертность от данного заболевания занимает третье место среди всех злокачественных новообразований [1].

К сожалению, более половины больных данной патологией, на момент обращения в онкологический стационар, не подлежат хирургическому лечению [2]. Радикальная хирургическая резекция возможна менее чем в половине случаев. Основной причиной отказа пациенту в операции является местная распространенность опухолевого процесса, либо обширное лимфогенное и гематогенное метастазирование – более, чем у 75% пациентов, на момент выявления заболевания, имеется поражение лимфатических узлов [3]. Даже после радикальной операции, около 20% больных страдают от дисфагии, вызванной либо рецидивом опухоли, либо стриктурой анастомоза.

По этой причине, паллиативные методы выходят на первый план в лечении пациентов с опухолевой обструкцией пищевода. Эти методы включают в себя паллиативные резекции и шунты, лучевую и химиотерапию, периодическое бужирование и баллонную дилатацию, абляцию опухоли с помощью неодим-иттриевого-алюминий-рубинового лазера, установку пищевода стента или эндопротеза, чрескожную гастростомию или комбинацию вышеперечисленных методов [4]. Основой для решения вопроса о тактике паллиативного лечения является возможность улучшения качества жизни и социальной адаптации пациентов с учетом распространенности заболевания, функционального статуса, а главное – прогноза его дальнейшего течения [5].

Опухолевые обструкции пищевода лечат с помощью паллиативного эндопротезирования вот уже более 100 лет. Первые протезы из слоновой кости и самшита устанавливались через рот и фиксировались снаружи, в одном случае даже с помощью привязывания протеза к усам [6]. Наступление эры гибкой эндоскопии и использование флюороскопического контроля позволило существенно увеличить безопасность установки жестких пищеводных стентов, хотя ее ни в коей мере нельзя было назвать нерискованной процедурой. Стандартом являлась подготовительная дилатация пищевода за 4-5 дней до введения жесткого эндопротеза до размеров, на 2-4 Fr превышающих диаметр самого протеза (48-51 Fr – 16-17 мм). При этом количество непосредственных осложнений превышало 20%, а летальность при метаанализе опубликованных серий составила 8,6% [7]. Непосредственными осложнениями являлись кровотечения, перфорации, нарушение дыхания вследствие сдавления трахеи, смещение эндопротеза. Отдаленные осложнения включали миграцию протеза, стриктуру пищевода с последующим кровотечением или образованием эзофаготрахеальной фистулы. Описаны обрастание протеза опухолью, хроническая аспирация и окклюзия просвета трубки комками пищи. Вот почему жесткие пластиковые стенты практически перестали применяться в клинике после появления существенно более безопасных и эффективных саморасширяющихся стентов.

Разработка и внедрение саморасширяющихся пище-

водных стентов преследовали цель уменьшения числа осложнений, связанных как с процедурой, так и с самими стентами. В отличие от жестких эндопротезов установка саморасширяющегося стента технически проще и сопряжена с меньшим риском кровотечения или перфорации, к тому же не требуется избыточной преддилатации пищевода. Упругая и в то же время гибкая конструкция саморасширяющихся стентов позволяет использовать их даже при наличии существенной извитости сужения. Несмотря на значительно более высокую стоимость металлических саморасширяющихся стентов, исследования подтверждают их большую безопасность и эффективность по сравнению с пластиковыми эндопротезами за счет снижения частоты и тяжести осложнений и как следствие – количества повторных вмешательств. При этом уменьшается время пребывания пациента в стационаре и достигаются лучшие качество и большая продолжительность жизни больных [8].

Для определения локализации и протяженности стриктуры вначале выполняется эзофагография. Пациент размещается на флюороскопическом столе на левом боку. Используется седация, область глотки обрабатывается лидокаиновым спреем. Для прохождения стриктуры применяют подходящие ангиографические проводники и катетеры. Проводник и катетер заводят в 12-перстную кишку, чтобы обеспечить максимально стабильное их положение, после чего обычный проводник меняют на более жесткий. Для преддилатации стриктуры перед установкой стента используют 15-миллиметровый баллон, заполняемый контрастом, разбавленным наполовину водой. После преддилатации по проводнику под флюороскопическим контролем в пищевод проводится стент на доставляющей системе. Необходимо, чтобы он по длине покрывал дополнительно по 2-3 см пищевода от каждого края опухоли. Рекомендуется примерно 60% длины стента располагать над серединой стриктуры, чтобы уменьшить риск возможной его миграции. Протяженные стриктуры могут потребовать несколько стентов, перекрывающих друг друга.

Сразу после стентирования с целью выявления возможных осложнений процедуры (например, перфорации пищевода) и для подтверждения проходимости стента в пищевод через катетер вводится неионный контрастный препарат. После прекращения действия седативных препаратов больному можно позволить выпить небольшое количество воды. На следующий день снова выполняется эзофагография для уточнения необходимости дополнительных вмешательств. Например, недостаточно раскрывшийся стент может потребовать дополнительной баллонной дилатации. При миграции устройства возможна установка дополнительного стента. При этом следующий стент устанавливается коаксиально с наложением на предыдущий эндопротез, что предотвращает дальнейшую миграцию. Если по данным эзофагографии подтверждается правильное положение и проходимость стента, пациент может быть переведен на пероральное питание. Рекомендуется употребление измельченной пищи с тщательным ее пережевыванием и употребление карбонатной минеральной воды после еды для уменьшения рефлюкса и очищения просвета стента.

Пищеводный рефлюкс периодически возникает у любого пациента после установки стента, особенно после стентирования пищевода-желудочного соединения.

Симптомы рефлюкса хорошо контролируются назначением омепразола после процедуры. В последнее время появились также стенты с антирефлюксным клапаном, который, однако, не исключает рефлюкс полностью.

Непосредственный технический успех может быть достигнут в 100% случаев с уменьшением степени дисфагии у 83-100% пациентов [9, 10, 11]. Непокрытые стенты прорастают опухолью в 20-30% наблюдений, в то время как покрытые стенты только в 2%. С отсутствием покрытия связано, однако, то, что непокрытые стенты почти не мигрируют. Миграция стента встречается в 30% использования покрытых Wallstent'ов и только в 10-15% случаев использования стентов Gianturco (СООК, Дания), особенно если они устанавливаются в пищеводно-желудочный переход, когда свободный конец протеза открывается в желудок. Новая конструкция стентов с непокрытыми участками по краям значительно уменьшает вероятность миграции [12].

Таким образом, паллиативное лечение дисфагии при неоперабельной карциноме пищевода или рецидиве карциномы на месте анастомоза – важная проблема, требующая решения. Стентирование пищевода является современным, малоинвазивным и эффективным методом лечения данной патологии.

Литература

1. Арзыкулов Ж.А., Ермекбаева Б.Е., Сейтказина Г.Д., Науанова

Л.Т. Показатели онкологической службы Республики Казахстан за 2000 год (статистические материалы). – Алматы. – 2001. – 48 с.

2. Давыдов М.И., Полоцкий Б.Е., Стилиди И.С., Тер-Ованесов М.Д. Рак пищевода: современные подходы к диагностике и лечению. – М., «Русский медицинский журнал», том 14, № 14. – 2006. – с. 28-32.

3. Renkin S., Mason R. // Clin. Radiol. – 1992. – Vol. 461. – P. 373-377.

4. Low D.E., Kozarek R.A. // The esophagus: medical and surgical management // Hill L.E., McCallum R. W., Mercer D.E. et al. – Philadelphia: Sanders, 1998. – P. 47-59.

5. Скобелкин О.К., Топчиашвили З.А., Тельных М.Ю., Коньков М.Ю. Палиативное лечение рака пищевода (современные направления). – М., «Русский медицинский журнал», том 4, № 7. – 1996. – с. 3-6.

6. Knyrim K., Wagner H.J., Bethge N. et al. // N. Engl. J. Med. – 1993. – Vol. 329. – P. 1302-1307.

7. Kozarek R.A. // Gastroenterologist. – 1994. – Vol. 2. – P. 264-272.

8. Low D.E., Kozarek R.A. // The esophagus: medical and surgical management // Hill L.E., McCallum R.W., Mercer D.E. et al. – Philadelphia: Sanders, 1998. – P. 47-59.

9. Cwikiel W., Stridbeck H., Tranberg K.G., et al. // Radiology. – 1993. – Vol. 187. – P. 661-665.

10. Saxon R.R., Barton R.E., Katon R.M. et al. // Journal of Vascular and Interventional Radiology. – 1995. – Vol. 6. – P. 747-754.

11. Song H.Y., Do Y.S., Han Y.M. et al. // Radiology. – 1994. – Vol. 193. – P. 689-695.

12. Sander R.R., Poesl H. // Endoscopy. – 1993. – Vol. 25 (suppl.). – P. 679-682.